



## جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) \* طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : دانارا ساجينوفنا اوسينوفا .  
 المحافظة : الجيزة  
 العمر (تاريخ الميلاد) : 03-02-1965  
 رقم البطاقة : 26502038800187  
 رقم التليفون : 01000623734  
 العنوان : ش حسين الترساوى  
 تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026  
 المهنة : ربه منزل

### الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك  
 الإخصائي الاجتماعي  
 التوقيع: (-----)  
 المقر بما فيه  
 التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

### تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني  
 الوظيفة :  
 التوقيع :  
 الاسم : د/ندى حسن  
 الوظيفة :  
 التوقيع :  
 الاسم : د/نرمين رمضان  
 الوظيفة :  
 التوقيع :  
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.  
 كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.  
 تعتمد صحة البيانات المرفقة  
 رئيس اللجنة ومدير  
 المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

### أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

### قرار اللجنة

التشخيص النهائي :  
 خطة العلاج :  
 المستشفى :  
 قسم :  
 نفقات :  
 جهة العلاج :  
 ملاحظات :

ختم  
 شعار الجمهورية

مدير عام  
 مديرية الشؤون الصحية

رئيس  
 المجلس الطبي المتخصص

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name:</b> دانارا ساجينوفنا اوسينوفا<br><b>National ID:</b> 26502038800187 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|           |
|-----------|
| تقرير طبي |
|-----------|

|                  |
|------------------|
| السيد            |
| تحية طبية وبعد,, |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| إيماء للطلب المقدم من | بشأن تقرير طبي للمريض |
| بقسم:                 | رقم طبي:              |

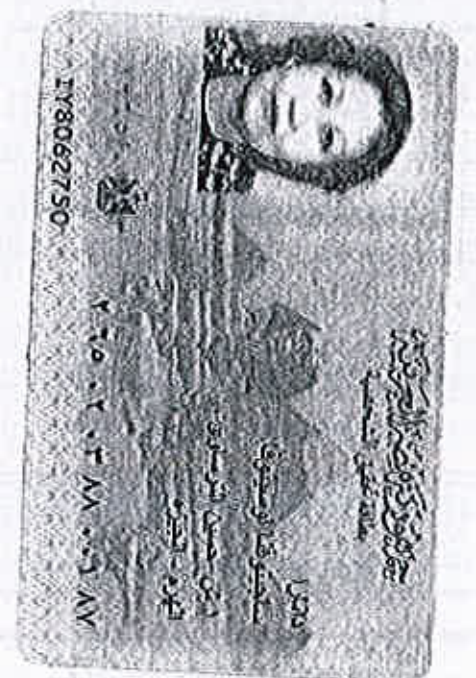
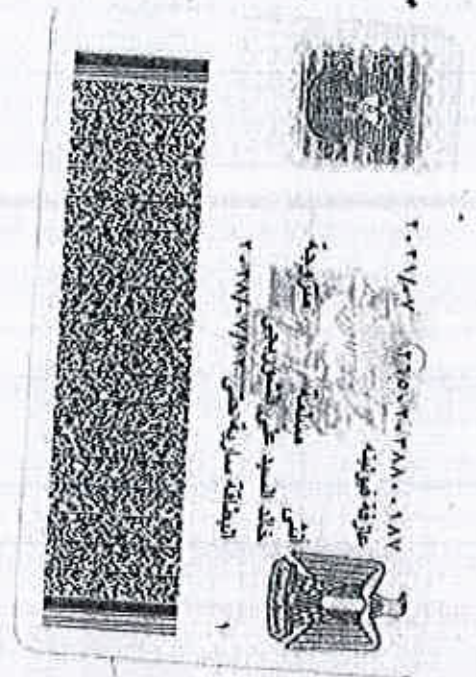
|                                          |
|------------------------------------------|
| نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته |
|------------------------------------------|

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| تاريخ وساعة الدخول :<br>-- --:-- yyyy-mm-dd | تاريخ وساعة الخروج :<br>PM 01:17 05-07-2026 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه |
|----------------------------------------|

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| التاريخ :<br>05-07-2026 | الوقت :<br>-- --:--               |
|                         | الطبيب المعالج :<br>د/شيماء لاشين |







# MDT FORM

11 / 10 / 2022

Post to  
20/8/2022

|                   |               |                |                 |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Name              | د. انار اسحاق | MRN            | 1-714444        |
| Age               | 57 yrs        | ID             | 1-754444        |
| Menopausal status |               | Phone          | 970-5-XXXX-XXXX |
| NRS SCORE         | 2             | marital status |                 |
| BMI               | obese I       | Family history |                 |
| Co morbidity      | Hysterectomy  | REASON OF MDT  |                 |

## Clinical Data

Bx: Rt breast Ca IDCN

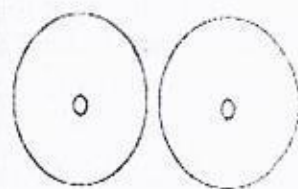
ER: 4/8 PR: 4/8 HER2: (3+) Ki67: 80

ER: 4/8 PR: 4/8 HER2: (3+) Ki67: 80

Sonogram: - Rt breast Mass.

Mets Workup: pt had Rt breast Ca T2 N0

2014 -> Post  
- Rt



T N M

## Recommendations:

post RT + MRH + Post MACT

-> free margins

LN -> 0/6

Complete pathological response.

④ TCSP X4

## MDT OUTCOME & PLAN

for 1 yr -> Paclitaxel/Hecatin

## SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

psychiatric

SV

Dr. M. J. J.

Dr. M. J. J.

11/10/22

Angela Hill 11/10/22



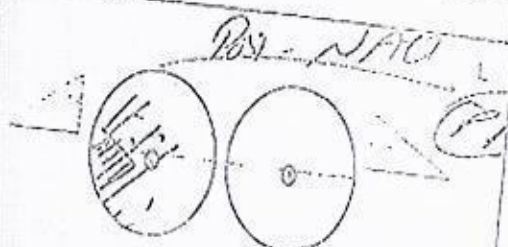
# MDT FORM

24/1/2022

|                   |                |                |             |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| Name              | 24/1/2022      | MRN            | C-CC/180    |
| Age               | 30/8           | ID             | 570-5-PA-14 |
| Menopausal status | Postmenopausal | Phone          | 7118-AT     |
| OCP               |                | Marital status |             |
| Co morbidity      |                | Family history |             |

## Clinical Data

|                        |     |        |       |
|------------------------|-----|--------|-------|
| ER:                    | PR: | HER 2: | K167: |
| 0/8                    | 3/8 | (+3)   | 80%   |
| Sonoma mammography 1/8 |     |        |       |
| In: 1 2 No in (2/14)   |     |        |       |



## Mets Workup:

## Recommendations:

In 2014, Rt breast Ca. T2N0  
 Rt CBS → PORT → Tam x 5yrs  
 Rt breast mm  
 L GR 0/8, PR 3/8, HER 2+  
 Started Herceptin

## MDT OUTCOME & PLAN

For Rt. MPR to include  
 skin nodules on the lower  
 the sternum.



## MEDICAL ONCOLOGY

## SURGERY

## SIGNATURE

## RADIOLOGY

## PATHOLOGY

Y. E. /

(Signature)

(Signature)

6/11/22



|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Patient Name: Danara Saginofna Aosinofa | Patient ID: 26502038800187 |
| Study Date: 3/12/2022                   | Age: 57 Years              |

### Contrast Enhanced Mammogram study:

- Bilateral mild background parenchyma enhancement
- Right UOQ heterogeneously enhancing ill defined speculated mass with related anterior area of non mass enhancement, totally measuring 5x3 cm in MLO view, about 6 cm from the nipple.
- Right axillary enhancing (nodal) mass about 3x3.5 cm
- Another two inner central small enhancing foci seen in cc and not appreciated in MLO extending 7.7 cm from the dominant mass measuring 2x3 mm and 7x4 mm and about 7 cm from the index lesion, extending 5 cm from the nipple (in MLO view); complementary targeted US revealed small-right 3 o'clock hypoechoic tiny nodules about 7x5 mm and 3x4 mm., another right UIQ two subcutaneous nodules measuring about 11x7 mm and 2x3 mm.
- No left breast significant sizeable enhancing masses or areas.

### Conclusion:

- ✓ Right UOQ. Malignant enhancing mass as described with two UIQ enhancing foci and UIQ subcutaneous nodules as described (BIRADS 5). For histopathological correlation.
- ✓ No left breast significant sizeable enhancing masses or areas (BIRADS 1).

*Thanks for referral,*

*Dr. Neryn Gamal, MD*

*Dr. Laila Bassam, MD*

Women imaging

Date & Time: 3/12/2022 11:02:25 AM





التصوير الشعاعي

وحدة تشخيص أمراض الثدي

قسم الباثولوجي

## IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Name: د. سارة بن علي

Pathology Number: 35/2022

Age: 57Y.

Patient's ID: 26502038800187

Date: 11/4/2022

**CLINICAL DATA:** A case of right breast & axillary tail duct carcinoma, for estrogen, progesterone receptors, Her-2/neu and Ki-67.

**PROCEDURE:** Sections from paraffin blocks were treated with antigen retrieval solution and then treated with monoclinal antibodies for estrogen, progesterone & Her-2/neu, (CONFIRM<sup>TM</sup> anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit & CONFIRM<sup>TM</sup> anti-Progesterone Receptor (PR) (VE2) & CONFIRM<sup>TM</sup> anti-HER-2/neu (486) Primary Antibody), CONFIRM anti-Ki67 (30-9) Primary Antibody, using Ventana View<sup>TM</sup> system. DAB was used as a chromogen and hematoxylin as a counter stain.

### RESULTS:

| Right Breast Mass                                                                                                                      | Right Axillary Tail mass                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examination of section treated for estrogen receptors revealed negative nuclear staining of tumor cells by chromogen.                  | Examination of section treated for estrogen receptors revealed negative nuclear staining of tumor cells by chromogen.                  |
| Examination of section treated for progesterone receptors revealed weak positive nuclear staining in 20% of tumor cells by chromogen.  | Examination of section treated for progesterone receptors revealed weak positive nuclear staining in 10% of tumor cells by chromogen.  |
| Examination of section treated for Her2/neu revealed strong complete membrane staining in >10% of tumor cells by chromogen (score 3+). | Examination of section treated for Her2/neu revealed strong complete membrane staining in >10% of tumor cells by chromogen (score 3+). |
| Examination of section treated for Ki-67 revealed positive nuclear stain in average of 80% of tumor cells.                             | Examination of section treated for Ki-67 revealed positive nuclear stain in average of 80% of tumor cells.                             |





**CONCLUSION:**

Tumor Cells Were:

| <u>RIGHT BREAST</u>                                       | <u>RIGHT AXILLARY TAIL</u>                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <u>Negative</u> For Estrogen Receptors,<br>Score 0/8.     | <u>Negative</u> For Estrogen Receptors,<br>Score 0/8.     |
| <u>Positive</u> For Progesterone Receptors,<br>Score 4/8. | <u>Positive</u> For Progesterone Receptors,<br>Score 3/8. |
| <u>Positive</u> For Her-2/neu (Score 3+).                 | <u>Positive</u> For Her-2/neu (Score 3+).                 |
| Ki-67: 80%                                                | Ki-67: 80%                                                |

COMMENT: All controls show appropriate reactivity.

PROF. DR. AHMED ABDEL AZIZ.

A ✓



شاربېنج الاصلدار: 2023-1-25

الى من يهمل الامر .....

العدد: (5) دشارا ماسينونوتا اوسونونفا  
بطاقة رقم 26502038800187  
وطبقا الى طلب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانقاع  
يشتر من الخلفات غير المعقولة بالتأمين الصحي  
وشكرا

تاریخ الطباعت: 2023-1-25



الإدارة مركز نظم المعلومات  
بجدة



السلامة على لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلى حالة تنفيذ حالة المواطن من قبل الدولة الشورية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الشورى والتعليم

الإدارة المركزية للتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار





## PATHOLOGY REPORT

Name: د.انار ماجينوفنا اوسرنوفا

Age: 57 Y.

Patient's I.D.: 26502038800187

Pathology Number: 35/2022

Date: 19/03/2022

Clinical data: Right UOQ breast mass & right axillary tail mass.

Nature of the specimen: U.S. Guided Tru Cut Biopsy.

### GROSS EXAMINATION: Two specimens:

- 1) Right UOQ breast mass: Tissue core biopsy, totally submitted.
- 2) Right axillary tail mass: Tissue core biopsy, totally submitted

MICROSCOPIC EXAMINATION: Serial sections examined from *both specimens* received revealed cores of malignant epithelial tumor formed of sheets and groups of moderately to markedly anaplastic ductal epithelial cells, with poor attempts at tubular formation. Areas of tumoral necrosis were seen, as well as mildly dilated ducts with luminal calcification. Surrounding desmoplastic stroma was seen, showing <10% T.I.L.S.

DIAGNOSIS: Right UOQ Breast Mass & Right Axillary Tail Mass, U.S. Guided Tru Cut Biopsy Specimens:

- BOTH SPECIMENS: Invasive Duct Carcinoma, NST, Grade II-III

DR. PASSANT ESSAM  
DR. YOUSRA RAAFIAT

Passant  
Yousra